

ProcedureIQ — Casos Hipotéticos para Validação de Domínio

Objetivo

Este documento não representa cálculos oficiais nem regras confirmadas da SBN ou CBHPM.

Seu objetivo é validar hipóteses de modelagem do sistema ProcedureIQ, responsável pelo cálculo de honorários médicos neurocirúrgicos a partir de procedimentos descritos em documentos da SBN e da CBHPM.

Os casos abaixo foram construídos a partir da interpretação preliminar dos documentos disponibilizados.

Hipótese Central do Sistema

A hipótese atual é que o cálculo segue o fluxo:

Procedimento Neurocirúrgico (SBN) ↓ Mapeamento para códigos CBHPM ↓ Determinação dos portes
↓ Aplicação das regras de remuneração ↓ Valor final

A principal dúvida a ser validada é:

- Os portes são simplesmente somados?
- Existe uma regra de procedimento principal e procedimentos acessórios?
- Existem regras específicas para múltiplos procedimentos?
- Como auxiliares e anestesia impactam o cálculo?

Caso 1 — Punção Lombar na Emergência

Componentes Identificados

Consulta em pronto-socorro — Porte 2B

Punção liquórica — Porte 2B

Curativo sem anestesia — Porte 1A

Valores Utilizados

2B = R\$ 141,05

1A = R\$ 26,74

Cálculo Hipotético

141,05

+ 141,05

+ 26,74

Total = R\$ 308,84

Questão para Validação

O valor final corresponde à simples soma dos portes envolvidos?

Caso 2 — Trauma Raquimedular Conservador

Componentes Identificados

Consulta em pronto-socorro — Porte 2B

Tratamento conservador do TRM — Porte 3C

Fratura/Luxação com redução incruenta — Porte 5B

Outras afecções da coluna — Porte 3B

Valores Utilizados

2B = R\$ 141,05

3C = R\$ 333,81

5B = R\$ 571,23

3B = R\$ 291,50

Cálculo Hipotético

141,05

+ 333,81

+ 571,23

+ 291,50

Total = R\$ 1.337,59

Questão para Validação

Todos os componentes participam integralmente do cálculo?

Caso 3 — Aneurisma Cerebral Não Roto

Componentes Identificados

Microcirurgia vascular intracraniana — Porte 14A

Ressecção do osso temporal — Porte 11B

Tratamento cirúrgico da fístula liquórica — Porte 10C

Reconstrução com retalho da gálea — Porte 8C

Reconstrução craniana — Porte 11A

Valores Utilizados

14A = R\$ 5.768,81

11B = R\$ 2.588,21

10C = R\$ 2.230,89

8C = R\$ 1.349,35

11A = R\$ 2.360,17

Cálculo Hipotético

5.768,81

+ 2.588,21

+ 2.230,89

+ 1.349,35

+ 2.360,17

Total = R\$ 14.297,43

Questões para Validação

Existe regra de múltiplos procedimentos?

Todos os portes são considerados?

Há distinção entre procedimento principal e procedimentos complementares?

Caso 4 — Tumor Intracraniano por Estereotaxia

Componentes Identificados

Microcirurgia para tumores intracranianos — Porte 14A

Tratamento da fístula liquórica — Porte 10C

Retalho da gálea — Porte 8C

Reconstrução craniana — Porte 11A

Valores Utilizados

14A = R\$ 5.768,81

10C = R\$ 2.230,89

8C = R\$ 1.349,35

11A = R\$ 2.360,17

Cálculo Hipotético

5.768,81

+ 2.230,89

+ 1.349,35

+ 2.360,17

Total = R\$ 11.709,22

Questão para Validação

O procedimento segue a mesma lógica aplicada aos aneurismas?

Caso 5 — Embolização de Tumor de Cabeça e Pescoço

Componentes Identificados

Embolização de tumor de cabeça e pescoço — Porte 8C

Cateterismo e estudo cineangiográfico — Porte 5A

Valores Utilizados

8C = R\$ 1.349,35

5A = R\$ 528,93

Cálculo Hipotético

1.349,35

+ 528,93

Total = R\$ 1.878,28

Questão para Validação

Os procedimentos endovasculares seguem as mesmas regras dos procedimentos cirúrgicos?

Perguntas Estratégicas para a Validação

1. O sistema deve somar todos os portes identificados?
2. Existe uma regra formal para múltiplos procedimentos?
3. Como os auxiliares são remunerados?
4. Como o porte anestésico é incorporado ao cálculo?
5. Todo procedimento SBN gera múltiplos códigos CBHPM ou apenas alguns?

6. Existem exceções importantes que deveriam ser consideradas desde a primeira versão do sistema?

Hipótese Atual de Arquitetura

Procedimento SBN ↓ Mapeamento SBN → CBHPM ↓ Determinação dos portes ↓ Aplicação de regras
↓ Cálculo do valor ↓ Resultado final

A principal entidade de domínio do ProcedureIQ provavelmente será o mapeamento entre procedimentos neurocirúrgicos da SBN e os códigos CBHPM correspondentes.